

Nr. 66 Vorstoß des Ministerialdirektors im Reichsinnenministerium Gütt zu seiner Etablierung als „Chef des Gesundheitswesens“ mit Übernahme des Reichsgesundheitsamts. 5./16./21. April 1939

R 1501/5583, S. 1–19, 127–137 *Ausfertigung/handschriftliche Stellungnahmen*¹

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsinnenministerium

a.: Vorlage des Ministerialdirektors Gütt für Reichsminister Frick. 5. April 1939

Vertraulich! Eilt!

Herrn Minister durch die Hand des Herrn Staatssekretär[s]² mit der Bitte um Entscheidung vorzulegen.

In der Anlage überreiche ich den Entwurf eines Erlasses des Führers und Reichskanzlers über die *Eingliederung des Reichsgesundheitsamts* in das Reichsministerium des Innern und *Einsetzung eines Chefs des Gesundheitswesens* nebst Begründung³.

Wie in der Begründung bereits ausgeführt worden ist, muß die Einrichtung des Reichsgesundheitsamts als selbständige Behörde als überholt angesehen werden⁴. Der an der Spitze des Amts stehende Präsident⁵ sah seine Aufgabe nicht mehr ausschließlich in der Beratung des für die volksgesundheitlichen Fragen zuständigen Reichsministers des Innern, sondern er fühlte sich und sein Amt für seine Fragen selbst verantwortlich. Diese Bestrebungen haben nicht nur zu Mißhelligkeiten mit dem Reichsministerium des Innern, sondern auch mit dem Stellvertreter des Führers geführt, der infolgedessen bei dem Herrn Minister mehrfach eine Änderung des bestehenden Zustandes und eine Abberufung des Präsidenten Dr. Reiter angeregt hat. Wie mir Ministerialdirektor Dr. Weber⁶, den ich vertraulich von der beabsichtigten Lösung in Kenntnis gesetzt habe, mitteilt, haben sich dieselben Mißstände auch im Veterinärwesen herausgebildet, so daß auch er eine Zusammenfassung der Aufgaben für erforderlich hält. Eine hiernach notwendig werdende Umbildung des Reichs-

¹ Zur personellen Reorganisation im Gesundheitswesen 1939, jedoch nicht zu diesem Vorschlag, s. LABISCH/TENNSTEDT, Weg II, S. 344–349; NELIBA, Frick, S. 196 f.; SÜSS, „Volkskörper“, S. 47 f. – MD Arthur Gütt (1891–1949) leitete im RIM seit Febr. 1934 die Abt. IV: Volksgesundheit. Biograph. Notiz: LABISCH/TENNSTEDT II, S. 423 f.

² Mit Sichtvermerk des StS Pfundtner, 16. 4. Er arbeitete die Vorlage durch, brachte zahlreiche Unterstreichungen mit Fragezeichen an und legte dann sogleich am Rand und auf den Rückseiten mit rotem Kopierstift seine hs. Stellungnahme für RIM Frick dazu nieder: unten b.

³ Anl. 1: „Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Einsetzung eines Chefs des Gesundheitswesens im Reichsministerium des Innern“ mit Begründung: R 1501/5583, S. 21–33.

⁴ Es hieß dort, die Stellung des 1876 zur medizinischen- und veterinärpolizeil. Unterstützung des Reichsamts des Innern gegr. Reichsgesundheitsamts (RGA) habe sich seit Fusion des Reichs- mit dem Preuß. Innenressort 1934 und dem Ausbau der Abt. IV grundlegend geändert. Das RIM sei nun mit dem eigenen Unterbau der Gesundheitsverwaltung in der Lage, auf die Mitarbeit des RGA „in den meisten Fällen überhaupt zu verzichten“. Es erübrige sich daher, „neben der mit der Exekutive ausgestatteten Zentralinstanz eine Stelle mit beratender Tätigkeit bestehen zu lassen“, die doch nur „Doppelarbeit“ leiste und unnötige Kosten verursache. Das RGA sei künftig auf „reine Forschungstätigkeit“ zu reduzieren.

⁵ Hans Reiter (1881–1969): Hygieniker, 1933–45 Präs. des RGA. Biogramm: LABISCH/TENNSTEDT II S. 477 f.

⁶ Friedrich Weber (1892–1955): 1935 als MDgt. Leiter einer Unterabt., seit Apr. 1937 MD und erster Leiter der Abt. III: Veterinärwesen des RIM. LABISCH/TENNSTEDT II S. 510 f.

gesundheitsamts kann jedoch nur durch Organisationserlaß des Führers und Reichskanzlers vorgenommen werden, denn nur dann können entbehrlich werdende Beamte gemäß § 43 des DBG auf Wartegeld gesetzt werden. Nur dann würde sich auch die Möglichkeit bieten, den Präsidenten des Amts, Prof. Dr. Reiter, in den Wartestand zu versetzen, da er nicht zu den Beamten gehört, die nach § 44 des DBG jederzeit auf Wartegeld gesetzt werden können. Da er ein Einzelgehalt der Gruppe B 6 bezieht, kann er auch nicht in ein anderes Amt der gleichen Laufbahn, z. B. als Ministerialdirektant versetzt werden, sondern dies könnte nur mit seinem Einverständnis erfolgen. Falls jedoch seine Verwendung in Frage käme, die ich wegen des Mangels an geeigneten Kräften durchaus befürworten könnte, würde dann gegebenenfalls seine Beförderung zum Ministerialdirektor in Erwägung zu ziehen sein. Ohne daß das Reichsgesundheitsamt also eine Spitze des Gesundheitswesens im Reich gewesen ist, trat es sowohl innenpolitisch wie außenpolitisch als solche in Erscheinung, was bei einer Aufhebung dieser Einrichtung in der Öffentlichkeit und besonders in Kreisen des Gesundheitswesens wie der Ärzte als ein Fehlen jeder Spitze angesehen werden dürfte. Wie auch in der Begründung ausgeführt ist, würde daher die Schaffung einer solchen Spitze des Gesundheitswesens im Reichsministerium des Innern auch aus diesem Grunde sich als notwendig herausstellen. Bei der Zusammenlegung wird von dem Gesichtspunkt auszugehen sein, daß eine Vereinfachung der Verwaltung und eine erhebliche Ersparnis eintreten müssen. Es wird darauf hinauskommen, daß der Abteilung Volksgesundheit und der Veterinärabteilung des Ministeriums, wie aus der beiliegenden Anlage Nr. 2⁷ hervorgeht, nur diejenigen Referenten zugeteilt werden, deren Aufgaben bisher auf dem Verwaltungsgebiet lagen und mehr theoretischer Art waren. Bei den wissenschaftlichen und experimentellen Forschungsaufgaben wird eine Aufhebung verschiedener Abteilungen, wie ebenfalls in der Aufstellung angedeutet, und eine Übertragung dieser Aufgaben auf andere Dienststellen stattfinden müssen. Es dürfte allerdings ein Rest von experimentell-wissenschaftlich arbeitenden Abteilungen in der Zweigstelle Dahlem des bisherigen Gesundheitsamtes⁸ übrig bleiben, die zu einer reinen Forschungsanstalt, der „Reichsanstalt für Gesundheitsforschung“, zusammenzuschließen wären. Dies gilt insbesondere für die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Erb- und Rassenpflege wie der praktischen Bevölkerungspolitik, ferner auf dem Gebiete der Ernährungswissenschaft, der Arbeitshygiene und des Veterinärwesens. Auf diesen Gebieten gibt es keine dem Reiche gehörenden Institute, die diese Arbeiten übernehmen könnten, die aber für die Aufgaben des Innenministeriums oder des Vierjahresplans unerläßlich sind. Auf allen anderen Wissensgebieten dagegen würde eine Ersparnis eintreten; z. B. kann die chemische Abteilung des Reichsgesundheitsamts mit der Preußischen Landesanstalt für Lebensmittel-, Arzneimittel- und gerichtliche Chemie vereinigt werden. Desgleichen müßten alle anderen Aufgaben des Reichsgesundheitsamts einer nachgeordneten Behörde übertragen werden. Unter Bezugnahme auf die verschiedenen Eingaben der Abt. IV ist darauf hinzuweisen, daß die zentrale Organisation der Abteilung ihren Aufgaben zur Erhaltung und Förderung der Volksgesundheit nicht mehr gewachsen ist. Die Aufgabengebiete der Abteilung sind derart groß und die fast völlige Neuordnung auf dem Gebiet des Gesundheitswesens wie der hierzu gehörenden Berufsstände wirkt sich allmählich in allen früheren Referaten derart aus, daß eine ungeheure Überlastung aller Referenten eingetreten ist. Infolgedessen haben fast sämtliche Referenten die Verantwortung für die Erhaltung der Volksgesundheit auf ihrem Sondergebiet mir gegenüber abgelehnt, da sie weder in der Lage sind, die täglichen Eingänge laufend zu bearbeiten noch wissenschaftlich ihr Arbeitsgebiet zu verfolgen, geschweige denn sich im Altreich von dem Stand des Gesundheitswesens die erforderliche Übersicht zu verschaffen oder gar in Österreich und im Sudetenland neu aufzubauen. Dieser Ansicht muß ich selbst als Abteilungsleiter beitreten;

⁷ Anl. 2: „Vorläufige Vorschläge für eine Eingliederung des Reichsgesundheitsamts“; R 1501/5583, S. 35–41.

⁸ In der Zweigstelle Berlin-Dahlem des RGA waren lt. Anl. 2 zusammengefaßt die umfangreiche Abt. Erb- und Rassenpflege mit vier Unterabteilungen, ferner die Abteilungen Biochemie und Ernährungsphysiologie sowie eine experimentelle Unterabt. für Veterinärfragen.

sie wird auch von den beiden Unterabteilungsleitern geteilt⁹. Es bietet daher die Verschmelzung der theoretischen humanmedizinischen Abteilung des Reichsgesundheitsamts wie des Restes der österreichischen Abteilung Volksgesundheit des Bundesministeriums mit der Abteilung Volksgeundheit des Reichsministeriums des Innern nun endlich die Möglichkeit, die einzelnen Referenten zu entlasten und 3 Unterabteilungen zu errichten:

– a)

die Unterabteilung der Gesundheitsverwaltung einschl. sanitäts-polizeilichem Gesundheitsschutz, wie Durchführung der Maßnahmen auf dem Gebiet der Bevölkerungspolitik und der Erb- und Rassenpflege (MinDirigent Dr. Ermert),

– b)

die Unterabteilung Heilfürsorge und Gesundheitsfürsorge einschließlich Krankenhauswesen, Ärzte, Zahnärzte, Dentisten, Heilpraktiker, Schwestern, Rotes Kreuz wie des gesamten medizinischen Hilfspersonals (MinRat Dr. Cropp),

– c)

die wissenschaftlich-medizinische Unterabteilung einschließlich Forschungen, Institute, soweit sie für die Gesundheitsverwaltung unerlässlich sind.

Die Verteilung der Aufgabengebiete geht aus der Anlage Nr. 3¹⁰ hervor, aus der auch ersichtlich sein dürfte, daß die drei Gebiete derart groß sind, daß sie tatsächlich nur immer von je einem Abteilungsleiter übersehen werden können. Es kommt hinzu, daß die Gesundheitsverwaltung, wie aus den weiteren Anlagen hervorgeht, im Großdeutschen Reich mit ungefähr 86 Millionen Einwohnern fast 900 Gesundheitsämter zu verwalten hat, die schon allein im Rahmen von zwei Referaten wie bisher nicht mehr verwaltet werden können. Wie bereits erwähnt, wirkt sich aber die Neuordnung auch auf allen anderen Gebieten derart aus, daß die bisher sehr großen und umfangreichen Referate geteilt werden müssen. Wenn auf den Wunsch des Führers und der NSDAP eine solche *Neuordnung im Gesundheitswesen* auf fast allen Gebieten erfolgen mußte, so kann es von mir als Abteilungsleiter *nicht mehr verantwortet werden, allen diesen Aufgaben in der Zentralabteilung mit unzulänglichen Kräften gegenüberzustehen*. Ich verweise hierbei auf die weitere Anlage¹¹, die ich mündlich zu erläutern bereit bin.

Wie ich Herrn Minister gegenüber bereits Gelegenheit hatte auszuführen, stehe ich auf dem Standpunkt, daß es an sich richtig sein würde, die Aufgaben der staatlichen Gesundheitsverwaltung und des Hauptamtes für Volksgesundheit der NSDAP in einer Spitze zu vereinen, wobei selbstverständlich meine eigene Person absolut keine Rolle spielen darf¹². Falls dies aus grundsätzlichen Erwägungen, wie mir mitgeteilt wurde, nicht erwünscht erscheint, muß dann aber umso mehr die Gesundheitsverwaltung im Rahmen des Innenministeriums herausgehoben und gestärkt werden. Der verstorbene Reichsärztführer¹³ hat mir noch in der letzten großen Unterredung im Oktober 1938 erklärt, daß er die Errichtung eines „Staatssekretariats für das Gesundheitswesen“ im Innenministerium für erforderlich hält. Wenn es zu weiteren Schritten in dieser Angelegenheit nicht gekommen ist, so deshalb, weil sich der Gesundheitszustand Dr. Wagners dann immer mehr verschlechtert hat und ich persönlich es stets abgelehnt habe, ohne eine offene Rücksprache mit dem Herrn Minister an irgendeine organisatorische Frage von grundsätzlicher Bedeutung heranzugehen. Es muß jedoch betont werden, daß mir nunmehr der Zeitpunkt gekommen zu sein scheint,

⁹ MDgt. Ermert und MR Cropp; s. unten. – Die Personalstärke der Gesundheitsabt. IV war von Okt. 1933 bis Apr. 1939 von 7 auf 26 Referenten, von 5 auf 27 Expedienten (Sachbearbeiter im gehobenen Dienst) und von 3 auf 24 Registraturkräfte angeschwollen. Gegenüberstellung in R 1501/5583, S. 143–155.

¹⁰ Anl. 3: Einzelaufstellung der Sachgebiete der drei Unterabteilungen; ebd. Bl. 43–69.

¹¹ Am Rand Verweis auf Anl. 4; „Aufstellung der Berufe im Heilwesen“; ebd. S. 71.

¹² Zu den langjähr. Auseinandersetzungen über die Führung im Gesundheitswesen durch Staat oder Partei, in denen Gütt den Kompetenzanspruch des RIM stets vehement verfocht, vgl. ARH IV, Nrr. 100, 180 P. B, 183; ARH V, Nrr. 108 P. 3, 111. Darstellung: LABISCH/TENNSTEDT II S. 332–344.

¹³ Gerhard Wagner, am 25. 3. 1939 an Leukämie verstorben.

diese Frage endgültig zu klären. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß der Nachfolger Dr. Wagners schon von seiner Umgebung immer wieder dahingehend beeinflusst werden wird, die Spitze des Gesundheitswesens im Reich für sich zu erkämpfen. Andererseits geht es auch nicht an, daß die Gesundheitsverwaltung sowohl anderen Ressorts gegenüber als auch im Rahmen der inneren Verwaltung eine nicht ausreichende Stellung erhält, in welcher sie die Belange des nun einmal gerade im Dritten Reich wichtigen Gebiets des Gesundheitswesens zu vertreten und durchzusetzen nicht vermag. Wenn ich daher heute die *Errichtung eines Chefs des Gesundheitswesens im Reichsministerium des Innern* oder die Einrichtung eines *Staatssekretariats* für erforderlich halte, so tue ich das nicht für meine Person, sondern aus grundsätzlichen Erwägungen. Infolgedessen bin ich daher auch jederzeit bereit, mein Amt dem Herrn Minister wie dem Führer und Reichskanzler zur Verfügung zu stellen und dann den kommenden Reichsärzteführer als meinen Nachfolger zu empfehlen¹⁴, damit die Belange des öffentlichen Gesundheitsdienstes bei Staat und Partei entsprechend vertreten werden können. Es kommt hinzu, daß auch die Arbeitskraft eines Beamten nur dann der hier zu erfüllenden Aufgabe gewachsen sein kann, wenn die Stellung der betreffenden Persönlichkeit jedem erneut beginnenden Rivalitätskampf gewachsen ist. Ohne eine entsprechende Umorganisation der Abteilung Volksgesundheit und Sicherung der Stellung der Gesundheitsverwaltung im Rahmen der inneren Verwaltung würde es mir mein Gesundheitszustand nach dem erlittenen Unfall¹⁵ auch nicht mehr gestatten, die Verantwortung für die Leitung der Abteilung Volksgesundheit weiter zu tragen. Ich darf in diesem Zusammenhang erwähnen, daß ja auch das große Problem eines *Umbaues der gesamten Sozialversicherung und Errichtung einer Reichsfamilienausgleichskasse*¹⁶ irgendwann einmal in Angriff genommen werden müssen, so daß auch von diesem Gesichtspunkt aus die ganze Problemstellung für das Innenministerium von besonderer Bedeutung ist. Ferner ist nicht zu verkennen, daß die NSV über die reine Wohlfahrtspflege hinaus sich auf dem Gebiete der Volkspflege und Gesundheitsfürsorge betätigt¹⁷, so daß auch dieser gegenüber die Belange des Innenministeriums mehr und mehr zu wahren sein werden. Genau so liegt es aber auch auf dem Gebiet der Bevölkerungs- und Rassenpolitik, auf welchem das Rassenpolitische Amt der NSDAP die Führung und das Recht zur Betätigung verlangt. Ich weiß aber nicht, wie man allen diesen Bestrebungen als verantwortlicher Leiter des Gesundheitswesens in Deutschland gegenübertreten soll, wenn man weder das Recht zur Vertretung dieser Belange, noch die erforderlichen Arbeitskräfte dazu zur Verfügung gestellt erhält.

Abgesehen von meiner Person kann aber eine solche Entscheidung wie die *Einrichtung eines Chefs des Gesundheitswesens* die *Stellung des Reichsministeriums des Innern im ganzen nur festigen*, denn die Voraussetzung hierfür wäre, daß dieser Chef des Gesundheitswesens sich ganz anders als bisher für die *Zusammenarbeit mit den Dienststellen der NSDAP* insgesamt freimachen und durchsetzen muß. Was dazu im einzelnen zu geschehen haben wird, dürfte einer mündlichen Erörterung vorzubehalten sein. Auch wenn man die Konstruktion des Reichsinnenministeriums selbst in Rechnung stellt, dürfte es gerechtfertigt sein, das Gesundheitswesen durch eine Persönlichkeit vertreten zu lassen, die die Stellung eines Staatssekretärs innehat. Im Reichsministerium des Innern wird die innere Verwaltung von einem Staatssekretär geleitet¹⁸, dem selbstverständlich eine über die sonstigen Belange der einzelnen Gebiete hervorragende Stellung zukommt. Diesem Staatssekretär ist bereits ein zweiter Staatssekretär beigegeben¹⁹. Ferner untersteht die deutsche Polizei einem Chef,

¹⁴ Gütt ging allerdings noch davon aus, daß Kurt Blome, Beauftragter G. Wagners für das ärztl. Fortbildungswesen, zu dessen Nachfolger ernannt werde; LABISCH/TENNSTEDT II S. 344.

¹⁵ Gütt hatte im Nov. 1938 bei der Jagd einen Kopfschuß mit schweren Verletzungen der rechten Gesichtshälfte erlitten und ein Auge verloren, mit der Folge chronischer Entzündung der Gesichtsnerven. Er war außerdem seit 1937 schwer herzkrank.

¹⁶ Hinweise zu diesem seit 1934 immer wieder beschworenen, aber nie realisierten Ziel s. ARH V, Nr. 87 Anm. 10.

¹⁷ Vgl. Dok. Nr. 54.

¹⁸ StS Hans Pfundtner als offiziell „Leitender Staatssekretär“ des RIM.

¹⁹ StS Wilhelm Stuckart, zugleich Leiter der Abt. I: Verfassung, Gesetzgebung, Verwaltung und zivile Reichsverteidigung, mit vier Unterabteilungen.

der seiner Persönlichkeit und Stellung in der Partei entsprechend ganz besonders herausgehoben ist²⁰. Daneben besteht aber auch ein Staatssekretariat für den Reichsarbeitsdienst²¹, wie für den Sport²². Es dürfte daher bei dem jederzeit genau nachzuprüfenden *Umfang der Gesundheitsverwaltung* durchaus gerechtfertigt sein, nunmehr auch ein Staatssekretariat für das Gesundheitswesen einzurichten²³. Wenn man ferner die Konstruktion anderer Ministerien in Rechnung stellt, so ist festzustellen, daß in dem an sich doch verhältnismäßig kleinen Arbeitsministerium ein zweites Staatssekretariat für die Aufgaben der Reichsanstalt für Arbeitslosenversicherung errichtet worden ist²⁴. Im Reichspropagandaministerium bestehen drei Staatssekretariate²⁵, von denen das zuletzt errichtete für das Fremdenverkehrswesen doch wahrlich sich auch nicht im entferntesten an Umfang und Bedeutung mit den Aufgaben des Gesundheitswesens und der Gesundheitsverwaltung messen kann. Wenn daher nunmehr das Reichsgesundheitsamt und die österreichische Gesundheitsverwaltung dem Reichsministerium des Innern eingegliedert werden, dürfte es direkt zu einer Zurücksetzung des Gesundheitswesens im Reich führen, wenn man seiner Bedeutung nicht Rechnung zu tragen gewillt sein sollte. Es muß in diesem Zusammenhang auch darauf verwiesen werden, daß der autonome tschechische Staat eine recht gut organisierte Gesundheitsverwaltung und ein Gesundheitsministerium besitzt. Ferner hat z. B. auch das kleine Ungarn schon seit langem ein Staatssekretariat für das Gesundheitswesen eingerichtet, das dem Innenminister direkt unterstellt ist. Wie mir Staatssekretär Johan bei seinem Besuch²⁶ erläuterte, sei er der Vertreter des Innenministers auf diesem Gebiet mit der Einschränkung, daß er lediglich bei Gesetzen und Verordnungen, die die gesamte Verwaltung stark berühren, vorher ein Einverständnis mit dem Staatssekretär der inneren Verwaltung herstellen müsse.²⁷ Da mein persönliches Verhältnis zu Herrn Staatssekretär Pfundtner ein gegenseitig betont gutes stets gewesen ist, bedauere ich es außerordentlich, daß ich mich aus grundsätzlichen Erwägungen und auf weite Sicht gesehen für eine solche Neuorganisation mit meiner ganzen Persönlichkeit einsetzen muß.²⁸ Ich bin der Überzeugung, daß die Zusammenarbeit nach wie vor eine durchaus gute und zufriedenstellende sein würde. Infolgedessen bitte ich den Herrn Minister, mich im Beisein des Herrn Staatssekretär Pfundtner zu einer Besprechung dieser Frage zu empfangen. Da die Ernennung des neuen Reichsärztführers unmittelbar bevorsteht, bitte ich bei dem kommenden Empfang die grundsätzliche Zustimmung des Führers und Reichskanzlers zu der beabsichtigten Umbildung erwirken zu wollen. Es wäre durchaus erwünscht, wenn die Ernennung des künftigen Reichsärztführers und des Chefs der Gesundheitsverwaltung gleichzeitig erfolgen würde, was aus psychologischen Gründen zu einer Beruhigung der beteiligten Kreise bei Partei und Staat beitragen würde.

Dr. Gütt
Ministerialdirektor.

²⁰ RFSSChDP Heinrich Himmler, eingesetzt durch FüE vom 17. 6. 1936 (RGBl. I S. 487); s. ARH III, Nrr. 98, 101, 105.

²¹ RAF StS Konstantin Hierl; s. ARH II/1, Nr. 122 Anm. 2.

²² Reichssportführer Hans v. Tschammer und Osten, seit Dez. 1936 Leiter der Abt. VIII: Sport und Leibesübungen, Ernennung zum StS am 12. 4. 1938; s. R 43 II/1136c, Bl. 104 ff.

²³ Am Rand Verweis auf Anl. 5: Personeller Ausbau der Gesundheitsverwaltung mit Verzeichnis der Gesundheitsämter, und Anl. 6: Sonderdruck mit Aufsätzen von MR Cropp, MD F. Weber und Prof. Ernst Rüdin zum fünfjähr. Amtsjubiläum Gütt's am 19. 2. 1939; R 1501/5583. S. 73–126.

²⁴ Besetzt mit StS Friedrich Syrup in Verfolg der Eingliederung der RAVAV als „Reichsstock für Arbeitseinsatz“ ins RAM; s. Dok. Nr. 29.

²⁵ StS Karl Hanke und Reichspressechef Otto Dietrich (beide ernannt am 26. 11. 1937 mit Wirkung vom 15. 1. 1938; s. ARH IV, Anhang FV 486*), StS Hermann Esser als Präs. des Reichsfremdenverkehrsverbands (ernannt am 27. 1. 1939; unten Anhang, FV 6*).

²⁶ Hierzu nichts ermittelt.

²⁷ Folgesatz von Pfundtner mit Randstrich und Fragezeichen versehen.

²⁸ Folgesatz von Pfundtner am Rand angestrichen und Marge „aber wie?“

b.: Stellungnahme des Staatssekretärs Pfundtner. 16. April 1939

Vertraulich!

Ich habe Herrn Dr. Gütt bei dem Auf- und Ausbau der Abteilung „Volksgesundheit“ stets weitgehend unterstützt und an den Arbeiten seiner Abteilung besonderen Anteil genommen. Besonders ist das während der Dauer seiner mehrfachen Erkrankungen der Fall gewesen. Ich bin also über den Umfang des Arbeitsgebiets der Abteilung einigermaßen unterrichtet und weiß auch, daß ein großer Teil der Referenten infolge der Angliederung der Ostmark, des Sudetenlands, Böhmen-Mährens und Memels neben ihrem alten Pensum mit neuen Aufgaben *stark* belastet ist. Das geht aber auch den *übrigen* Abteilungen des Hauses, in erster Linie I, II, V und Z²⁹ so! Auch die *Leitung* des Ministeriums hat einen erheblichen Arbeitszuwachs zu verzeichnen! *Hilfskräfte* stehen bei den starken *Abgaben* nach Österreich usw. in *keinem* unserer Verwaltungszweige in nennenswertem Umfang zur Verfügung. Wir werden uns also *überall* mit dem jetzigen Bestand – vielleicht noch verstärkt durch einige Beamte der demnächst aufzulösenden *österreichischen* Zentralregierung! – durchhelfen, *weniger dringliche* Aufgaben *zurückstellen*, vor allem aber uns *endlich* dazu durchringen müssen, zu unserer Entlastung unseren Unterstellen, insbesondere den Reichsstatthaltern, OPs und *Regierungen* in möglichst weitem Umfang *Aufgaben* und *Zuständigkeiten* zu *übertragen*! Das gilt für alle Sparten der inneren Verwaltung, also *auch* für die *Gesundheitsverwaltung*, die ein *Teil* derselben ist und bleiben muß!

Dies vorausgeschickt, stimme ich:

1. der vorgeschlagenen Auflösung des Reichsgesundheitsamtes unter Hereinnahme *einiger weniger* Kräfte in das Ministerium als „wissenschaftliche *Unterabteilung*“ der Abt. IV und unter besonderer Behandlung der Institute – siehe Vorschlag Gütt! – grundsätzlich zu, vorausgesetzt, daß dadurch wirklich *nennenswerte* personelle und sachliche Ersparnisse erzielt werden. Alles Nähere müßte hier noch mit den Abteilungen Z, I und II erörtert werden. Auch mit Präsident *Reiter* müßte schon wegen seiner eigenen Person, und zwar zweckmäßig durch den H[errn] Minister oder durch mich, verhandelt werden. Jedenfalls verdient er als alter Pg., den wir vor 6 Jahren nach Berlin geholt haben, eine rücksichtsvolle Behandlung, für die auch die Partei m. E. eintreten wird.

2. Dagegen muß ich mich im Interesse der *Einheitlichkeit* des Gesamtministeriums und der *Einheit* der allgemeinen und inneren Verwaltung entschieden *gegen* die Einsetzung eines „Chefs des Gesundheitswesens“ aussprechen. Die Gesundheitsverwaltung ist *kein Ding an sich*, sondern bildet nur einen, wenn auch wichtigen Teil der großen allgemeinen Verwaltung und muß deshalb auch in der Spitze, d. h. im Ministerium *einheitlich* mit den übrigen Zweigen durch den Staatssekretär des Gesamtministeriums geleitet werden³⁰. Beamten-, Etats-, Gesetzgebungs- und unzählige andere Fragen, die alle Zweige der inneren Verwaltung *gleichmäßig* berühren, müssen *einheitlich* behandelt und entschieden werden, was nur durch den Staatssekretär des Gesamtministeriums als ständigen Vertreter des Ministers geschehen kann.

²⁹ Zur Abt. I oben Anm. 19. Abt. II bildete die Personalabt. (MD Schütze) mit der Unterabt. Beamtentum (MDgt. Seel), V die Kommunalabt. (MD Surén), Z die Zentralabt. unter StS Pfundtner selbst (Vertreter MDgt. Wöllke).

³⁰ In der dem FfE-Entw. beigegebenen Begründung Gütt's (o. Anm. 3) stieß sich Pfundtner, wie aus den Anstreichungen ersichtlich, denn auch v. a. an folg. Passagen: Die Gesundheitspflege als umfassende und „in sich geschlossene Aufgabe von höchster Bedeutung für die Festigung der völkischen Belange des Nationalsozialismus“ könne auf Dauer „nicht im Rahmen einer Abteilung des Reichsministeriums des Innern bewältigt werden“. Wenn gleichwohl dem Vorbild anderer Länder nicht gefolgt und „ein selbständiges Ministerium nicht angestrebt werden soll, so wird hierbei von dem Grundsatz ausgegangen, die Einheitlichkeit der Verwaltung bis zur Grenze des Möglichen aufrechtzuerhalten. Wohl aber ist die ihrer Bedeutung und ihrer Aufgabe entsprechende Heraushebung der Gesundheitsverwaltung als besonderer Teil der inneren Verwaltung in der Zentrale gerade dann nötig, wenn eine Vereinheitlichung in den unteren Verwaltungsbezirken angestrebt wird. [...] Da die jetzige Organisation den verantwortungsvollen Aufgaben der Gesundheitsverwaltung weder in Friedens- noch in Kriegszeiten entspricht, ist eine Heraushebung zweckmäßig und in derselben Form erforderlich, wie sie bereits auf anderen Gebieten der Verwaltung erfolgt ist.“

Es kommt hinzu, daß „Chefs“ an sich nur bei „militärischen“ oder „militärähnlichen“ Organisationen (Polizei) vertretbar, bei den Ministerien dagegen nicht üblich und von uns bei *anderen* Ressorts stets bekämpft worden sind. Ein „Chef der Gesundheitsverwaltung“ wäre im übrigen ohne einen *über* ihm stehenden „Chef der inneren Verwaltung“ nicht gut denkbar!

Endlich würde es m. E. nicht verstanden werden, wenn *wir* in einem Augenblick, in dem wir die Gesundheitsämter in der *untersten* Instanz wieder beim Landrat *eingliedern*, in der *Spitze* einen Schritt unternehmen würden, der doch nur als Beginn einer *Trennung* aufgefaßt werden kann. Ich bin in dieser Hinsicht eben ganz anderer Auffassung als Herr Dr. Gütt und glaube auch nicht, daß es zur Durchsetzung der *staatlichen* Gesundheitspolitik eines „Chefs“ bedarf. Vielmehr ist dafür allein die Autorität des großen und alle Verwaltungszweige umfassenden Innenressorts erforderlich und ausreichend!

Polizei und Arbeitsdienst können hier zum Vergleich m. E. nicht herangezogen werden. Desgleichen auch nicht der Sport, dessen Leiter innerhalb des Ministeriums übrigens ebenso wie der Leiter der Abt. I die Stellung eines Abteilungsleiters hat.

Ich glaube hiernach, daß weder ein „Chef der Gesundheitsverwaltung“ noch ein *besonderer* Staatssekretär mit Vertretungsbefugnissen geschaffen werden kann, ohne das Ministerium *auseinanderzureißen* und eine einheitliche Leitung unmöglich zu machen.

Jedenfalls hätte der Staatssekretär des Gesamtministeriums als Vertreter des Ministers dann nicht mehr *die* Befugnisse, die er benötigt, um die *Einheit* des Ministeriums zu wahren und die nun einmal bestehenden Gegensätze der Abteilungen auszugleichen. *Seine* Stellung wäre dann ausgehöhlt und in Kürze unhaltbar!

Ich schlage also meinerseits vor, von der Schaffung eines „Chefs der Gesundheitsverwaltung“ ebenso abzusehen wie von der Schaffung eines Staatssekretärs als Vertreter auf diesem Gebiet.

Möglich ist nach meiner Ansicht nur die *Beibehaltung* der mit den anderen Abteilungen *gleichgestellten* Abteilung IV „Volksgesundheit“ mit Einschluß [?] dreier von *Dirigenten* geleiteter *Unterabteilungen*. Zur Hebung der Stellung des Abteilungsleiters wäre seine Beförderung zum „*Unterstaatssekretär*“ nach Maßgabe der z. Zt. schwebenden Verhandlungen mit Reichskanzlei und R[eichs]Fin[anz]Min[isterium]³¹ in Aussicht zu nehmen.

Pfundtner 16/4

c.: Verfügung von Reichsinnenminister Frick. 21. April 1939

Sofort

H. Pfundtner (IV)

Zu [sic] der nach dem „Neuen Finanzplan“³² erforderlichen Vereinfachung u. Verbilligung der Verwaltung bin ich mit der *Auflösung des RGA's* unter folgenden Voraussetzungen einverstanden.

1. Es darf dadurch *keine weitere Aufblähung des Apparats des R[eichs]M[inisteriums] d[es] I[nnern]* erfolgen entgegen der Tendenz der Verkleinerung der R-Zentralbehörden zur Erhöhung ihrer Leistungsfähigkeit unter Abstoßung aller minderwichtigen Dinge auf die Mittel- und Unterinstanzen.
2. Es dürfen anstelle des RGA's *keine neuen Organisationen* geschaffen werden. Soweit seine Aufgaben nicht auf das RIM übergehen, sind sie auf andere bereits vorhandene Institute (z. B. *Preußische* Institute unter Umwandlung in *Reichsinstitute*, Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft) zu übertragen.

³¹ Näheres s. Dok. Nr. 68.

³² Vgl. Dok. Nrr. 15, 47, 59.

Die Gesundheitsverwaltung bleibt *Abteilung* des RIM, ihre Spitze ist persönlich zu heben (Unterstaatssekretär!). Zur Entlastung des Staatssekretärs ist von der Befugnis zur „I. A.“-Zeichnung weitgehend Gebrauch zu machen.

Die Frage des RÄrzteführers hat der Führer bereits entschieden. Conti muß *heute* noch vom RIM nach Maßgabe der RÄO in seinem Amt bestätigt werden, damit *morgen* die Pressenotiz (Einsetzung von Partei *und* Staat!) erscheinen kann³³.

Nach weiterer Bereifung [sic] des Plans zur Auflösung des RGA's gemäß obiger Richtlinien stehe ich zur mündlichen Einzelerörterung der Angelegenheit zur Verfügung³⁴.

21. 4. 39

Fr[ick]

³³ Der Arzt Leonardo Conti (1900–1945), 1933–36 bereits MR in der Gesundheitsabt. des RIM, seit Nov. 1936 Stadtmedizinalrat von Berlin, war von Hitler am 20. 4. 1939 zum Leiter des HA für Volksgesundheit der NSDAP ernannt worden, unter Verleihung des Titels „Reichsgesundheitsführer“, der die Bezeichnung „Reichsärzteführer“ ersetzte. Seine Amtseinführung und die seines Stellvertreters Blome (o. Anm. 14) erfolgte am 22. 4.; R 43 II/719a, Bl. 6 (APK II, Reg. Nr. 13477). Biogramm: LABISCH/TENNSTEDT II S. 393–395.

³⁴ Pfundtner hatte Frick am 16. 4. auch ein Exposé des MD Schütze zur Eingliederung des RGA mit kurzem Organisationserlaß unterbreitet, und am 2. 5. meldete Gütt, er habe die Fusion soeben mit Präs. Reiter „in loyaler und kameradschaftlicher Weise“ besprochen, auch Conti befürworte sie; R 1501/5583, S. 119–123, 139–141 (APK II 3, Reg. Nr. 32543). Nach detaillierter Aufklärung durch Reiter über die Arbeitsgebiete des RGA gab Frick indes Ende Juli Weisung, die Auflösung solle „noch einmal in aller Ruhe geprüft werden“, und nach Kriegsbeginn wurde sie nicht weiterverfolgt; ebd. S. 157–221. Auch die Ernennung Gütt zum UStS unterblieb: Anhang, FV 212*. Ende Juni ging er in Krankheitsurlaub und stellte Anfang August sein Amt „vorläufig“ zur Verfügung. Am 27. 8. 1939 ernannte Hitler statt seiner Conti zum StS im RIM, womit dieser erstmals die Gesamtführung des Gesundheitssektors in Staat *und* Partei auf sich vereinigte. Er war Frick nun direkt nachgeordnet, nicht mehr Pfundtner; s. R 1501/5532, Bl. 165 (APK II 3, Reg. Nr. 32844). – Die von RIM und RAM ab Jahresende 1939 gemeinsam betriebene Ernennung Contis zugleich zum StS für die Sozialversicherung im RAM (Anhang, FV 385*) scheiterte jedoch am Widerstand Robert Leys und dessen eigenen Ambitionen auf Übernahme des Sozialressorts; hierzu näher R 1501/5572, S. 55–77; R 1501/5599, S. 281 ff. (APK II 3, Reg. Nr. 33226).

Nr. 66: Vorstoß des Ministerialdirektors im Reichsinnenministerium Gütt zu seiner Etablierung als „Chef des Gesundheitswesens“ mit Übernahme des Reichsgesundheitsamts. 5./16./21. April 1939a. Vorlage des Ministerialdirektors ...

Zitierhinweis

Nr. 66 Vorstoß des Ministerialdirektors im Reichsinnenministerium Gütt zu seiner Etablierung als „Chef des Gesundheitswesens“ mit Übernahme des Reichsgesundheitsamts. 5./16./21. April 1939a. Vorlage des Ministerialdirektors Gütt für Reichsminister Frick. 5. April 1939b. Stellungnahme des Staatssekretärs Pfundtner. 16. April 1939c. Verfügung von Reichsinnenminister Frick. 21. April 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d066>